

TEMA 3.28 • OBSTETRICIA

Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE)

PERFIL EUNACOM 2.01.2.022
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE)

Importancia

- **Riesgo materno Y fetal** — ambos pueden fallecer
- Conducta: **interrumpir de inmediato** ante la sospecha

Clínica

TABLA 3.28.1: CARACTERÍSTICA VS DETALLE	
CARACTERÍSTICA	DETALLE
EG	3er trimestre (siempre > 30 semanas)
Inicio	Insidioso: astenia intensa, anorexia, náuseas
Progresión	Ictericia, dolor abdominal, hipoglicemia
Grave	Encefalopatía hepática, coagulopatía, falla hepática fulminante
Fetal	Sufrimiento fetal agudo

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Astenia + hipoglicemia + coagulopatía en el 3er trimestre → sospechar HGAE.

Causa

Genética fetal — el feto tiene déficit enzimático para metabolizar ácidos grasos → se acumulan y pasan a la madre → intoxicación hepática.

- Puede recurrir en embarazos futuros
- Se indica estudio genético al niño y padres

Diagnóstico

TABLA 3.28.2: EXAMEN VS HALLAZGO	
EXAMEN	HALLAZGO
Transaminasas	Marcadamente elevadas (hepatitis)
Tiempo de protrombina / INR	Alargados (coagulopatía = falla hepática)
Glicemia	Hipoglicemia (hallazgo más frecuente y sugestivo)
Biopsia hepática	Gold standard (solo se hace si no se recupera post-parto o en autopsia)

NOTA CLÍNICA

La biopsia no se hace antes de interrumpir. La sospecha clínica + laboratorio es suficiente para indicar interrupción. Si se recupera tras el parto → diagnóstico confirmado por exclusión.

Tratamiento

- **Interrupción inmediata** (habitualmente cesárea por urgencia)
- **Soporte** de falla hepática (hipoglicemia, coagulopatía, encefalopatía)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Importancia
- Clínica
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Riesgo materno Y fetal
- interrumpir de inmediato
- | 3er trimestre (siempre > 30 semanas) | |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO (HGAE))**PREGUNTA 1**

Respecto a Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO (HGAE)

Genética fetal — el feto tiene déficit enzimático para metabolizar ácidos grasos → se acumulan y pasan a la madre → intoxicación hepática. ::::note La biopsia no se hace antes de interrumpir. La sospecha clínica + laboratorio es suficiente para indicar interrupción. Si se recupera tras el parto → diagnóstico confirmado por exclusión. :::: 1. Interrupción inmediata (habitualmente cesárea por urgencia) 2. Soporte de falla hepática (hipoglicemia, coagulopatía, encefalopatía)